

Informe de Evaluación Neuropsicológica de niños

Datos Personales

Nombre y Apellidos	Adrian García Hernandez
Fecha de Nacimiento	28 de Marzo 2015
Fecha de evaluación	26 de Septiembre 2024
Residencia	Manizales Caldas
Acompañante	Madre
Numero de Contacto	3143163795
Correo electrónico	yisedhernandezm@gmail.com

Historia del Paciente:

Paciente masculino en curso de vida infancia (9 años) Asiste en compañía de la madre yised Hernández (34 años) ilustradora, procedentes de Manizales, Paciente remitido por la especialidad de psiquiatría desde pequeño particularidades de conducta "problemas en socializar" selectivo tuvo en los alimentos no soporta estar descalzo los ruidos fuertes le molestan las marquillas de ropa le desagradan obstinado, llevado de su parecer a veces autoagresivo a veces heteroagresivo se obsesiona con aspectos, dinosaurios, astronomía lee de manera obsesiva esta en segundo, frente a los antecedentes perinatales primer y único embarazo de padres no consanguíneos edad de la madre (25 años) embarazo de alto riesgo emocionalmente muy inestable, parto "fue difícil dolores dos días y ya se dieron cuenta que el venia en mala posición cesarea de urgencias", no requirió hospitalización, egreso conjunto, madre con depresión postparto, lactancia materna 18 meses, frente al neurodesarrollo gateo trasero 9 meses, marcha impediendo 15, lenguaje establecido 2 años, frente a la historia escolar ingreso a los 3 años en el jardín exploradores "la profesora empezamos a notar que no toleraba los ruidos de los niños no contacto visual ni físico" (hijo hasta transición), ingreso a primero en la IE ENSM "fue pandemia que no quería hacer las cosas decía que eso ya lo sabía" "no socializaba" "actúa como sordo la gente habla y el no les responde", Abuela Montañita (pedagogía walford) Educación en casa un año por parte de la madre, actualmente vuelve a educación tradicional a la IE San Felipe en grado segundo bajo gusto e interés por la parte académica, atrasado, la profesora me dice que se mete debajo de una silla, en educación física se van de la mano con compañeros y el no lo permite", paciente reside en el barrio quinta hispana en familia monoparental yised Hernández (34 años) ilustradora, padres separados hace 3 años Daniel (36 años) Diseñador visual actualmente vive en España se trata de ser cercana pero adrian dice que no quiere, refiere red de apoyo familiar materno, frente al comportamiento en casa la madre refiere conductas estereotipadas aleteo manos, buen contacto visual, "depende es muy selectivo", dificultades para socializar, no tolera ruidos fuertes ni algunas texturas, le cuesta adaptarse a los cambios de rutina temas de interés astronomía, dinosaurios, aviones, comparte colecho en ocasiones con la madre, es independiente en avc, "su lenguaje es claro y muy bueno pero es selectivo para hablar"

1. Informe de evaluación de Nesplora aula

1.1 Descripción general

Nesplora Aula es un test de ejecución continua (CPT) que se realiza en un entorno virtual, mostrado a través de unas gafas especiales dotadas de sensores de movimiento y auriculares. Este instrumento está diseñado para evaluar los procesos de atención y ayudar en el diagnóstico de los trastornos de atención.

El escenario virtual que se presenta a través de las gafas es semejante a una clase de colegio y la perspectiva sitúa al sujeto en uno de los pupitres. El software actualiza la perspectiva en función de los movimientos de la cabeza, dando al sujeto la sensación de encontrarse en el aula.

En la pizarra virtual y a través de los auriculares se presentan una serie de estímulos a los que el sujeto deberá responder según las instrucciones. La prueba consta de dos ejercicios de evaluación. En el primero, se debe pulsar el botón cada vez que el estímulo presentado sea diferente al estímulo diana. En el segundo, se debe pulsar el botón cada vez que se escuche o vea el estímulo diana.

Los datos se muestran en gráficos y tablas. En cada uno de los párrafos se explican las puntuaciones obtenidas en relación al rendimiento del niño o niña: de 20 a 30 rendimiento muy bueno o muy alto en relación a la población de su edad y sexo, de 31 a 40 rendimiento alto, de 41 a 60 rendimiento normal, de 61 a 70 rendimiento bajo, y de 71 a 80 rendimiento muy bajo.



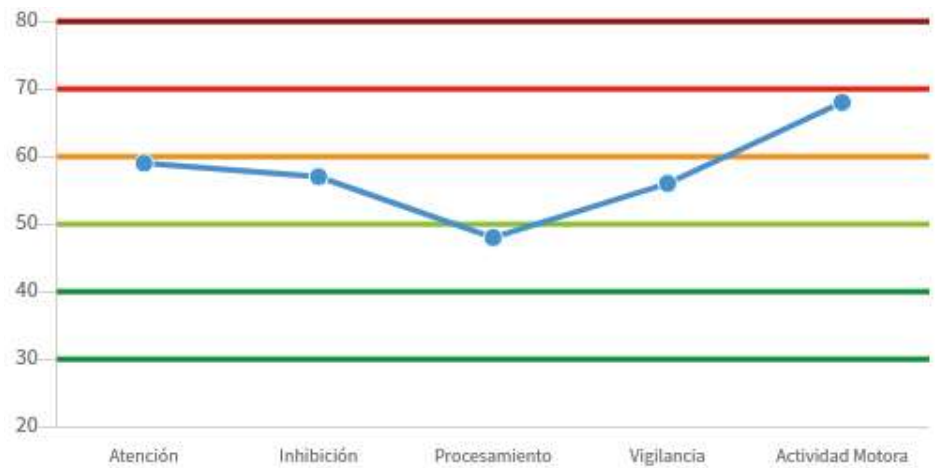
Para una mejor interpretación del informe, se recomienda consultar el manual de Nesplora Aula.

2. EVI – Indicador de validez

Para el filtro de esta evaluación se ha empleado un EVI (indicador de validez integrado). Este ratio (EVI) muestra si hay problemas de ejecución durante la administración de la prueba. Esto nos permite valorar si existe una posible incongruencia de ejecución que pudieran afectar a los resultados previo a considerar el diagnóstico clínico.

En el caso de **Adrian** , **esta evaluación cumple los requisitos para considerarse válida en su ejecución y se pueden analizar los resultados.**

3. Índices generales



Puntuaciones percentiles (PC)

Puntuaciones directas (PD)

Puntuaciones típicas (PT)

	PC	PD	PT
Atención: Omisiones Totales	83	47	59
Control inhibitorio: Comisiones totales	75	21	57
Procesamiento: Media TR-Aciertos	43	856.31	48
Vigilancia: (σ) Desviación típica TR-Aciertos total	74	427.19	56
Actividad motora total	96	1.97	68

3.1 Descripción de los índices

Atención Omisiones Totales



Ocurren cuando Adrian debe responder al estímulo diana y no lo hace. Los errores por omisión son considerados como una medida de inatención selectiva y enfocada. Adrian ha obtenido una puntuación 47 en Omisiones totales. Este dato se sitúa en un percentil 83 y t 59 respecto a la muestra normal. Lo que indica un **rendimiento normal**.

Control inhibitorio Comisiones totales



Se recolectan cuando no aparece el estímulo diana y se le da al pulsador. Las comisiones son errores interpretados como medidas de falta de inhibición de la respuesta o descontrol motor. Adrian ha obtenido una puntuación 21 en Comisiones totales. Este dato se sitúa en un percentil 75 y t 57 respecto a la muestra normal. Lo que indica un **rendimiento normal**.

Procesamiento Media TR-Aciertos



La media del tiempo de reacción es una medida muy fiable de la velocidad de procesamiento y de la consistencia de la respuesta. Refleja también la capacidad atencional. Adrian ha obtenido una puntuación 856.31 en Media TR-Aciertos total. Este dato se sitúa en un percentil 43 y t 48 respecto a la muestra normal. Lo que indica un **rendimiento normal**.

Vigilancia (σ) Desviación típica TR-Aciertos total



La desviación del tiempo de reacción es una medida de variabilidad o inconsistencia de respuesta y puede ser una medida del decremento de la vigilancia. Adrian ha obtenido una puntuación 427.19 en (σ) Desviación típica TR-Aciertos total. Este dato se sitúa en un percentil 74 y t 56 respecto a la muestra normal. Lo que indica un **rendimiento normal**.

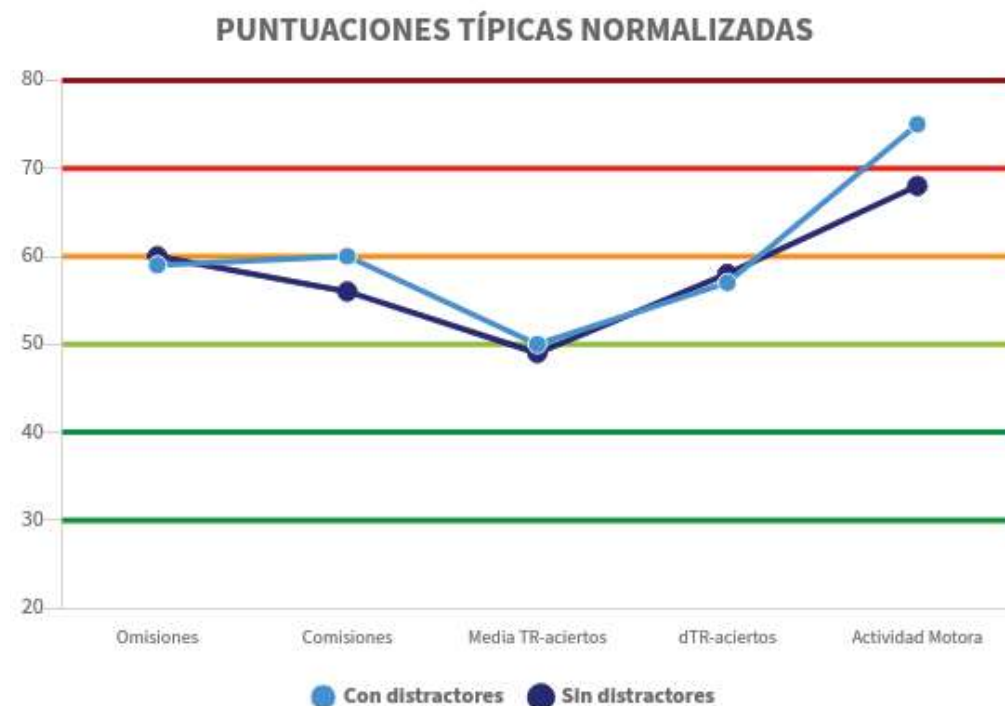
Actividad motora total



La actividad motora se mide con el sensor de las gafas, evalúa los movimientos de la cabeza del niño o niña mientras realiza el ejercicio, es decir, si se ha movido mucho o poco, o de manera innecesaria. Adrian ha obtenido una puntuación 1.97 en Actividad motora total. Este dato se sitúa en un percentil 96 y t 68 respecto a la muestra normal. Lo que indica un **rendimiento bajo**.

4. Ejecución de la tarea en presencia y ausencia de distractores

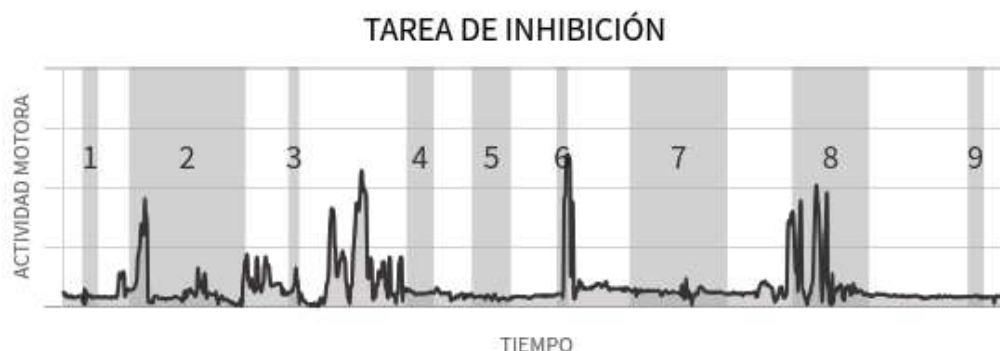
Nesplora Aula ha analizado el rendimiento de Adrian en presencia y ausencia de distractores, de manera que se puedan comparar sus resultados. Las tablas siguientes muestran cuanto afectaron los distractores a Adrian durante su prueba en Nesplora Aula.



	CON DISTRACTORES			SIN DISTRACTORES		
	PC	PD	PT	PC	PD	PT
Omissiones Totales	80	17	59	84	30	60
Comisiones totales	84	10	60	73	11	56
Media TR-Aciertos	51	878.59	50	46	840.1	49
(σ) Desviación típica TR-Aciertos total	77	409.08	57	77	439.19	58
Actividad motora total	98	2.1	75	96	2.03	68

4.1 Gráficos de actividad motora en relación con los distractores

Estos gráficos indican la actividad de Adrian en relación con los distractores presentados dentro de Nesplora Aula. Un pico de actividad en relación con un distractor significa que Adrian ha seguido con la cabeza al distractor, desatendiendo su tarea.



TAREA 1

1. Bola de papel	VISUAL
2. Paseo del profesor	VISUAL
3. Cuchicheo a la derecha	AUDITIVO
4. Se cae el boli del profesor	VISUAL
5. Un niño pasa una notita	VISUAL
6. Tos a la izquierda	AUDITIVO
7. Un niño entrega una hoja al profesor	VISUAL
8. Pasa una ambulancia	VISUAL
9. Suena una campana	AUDITIVO

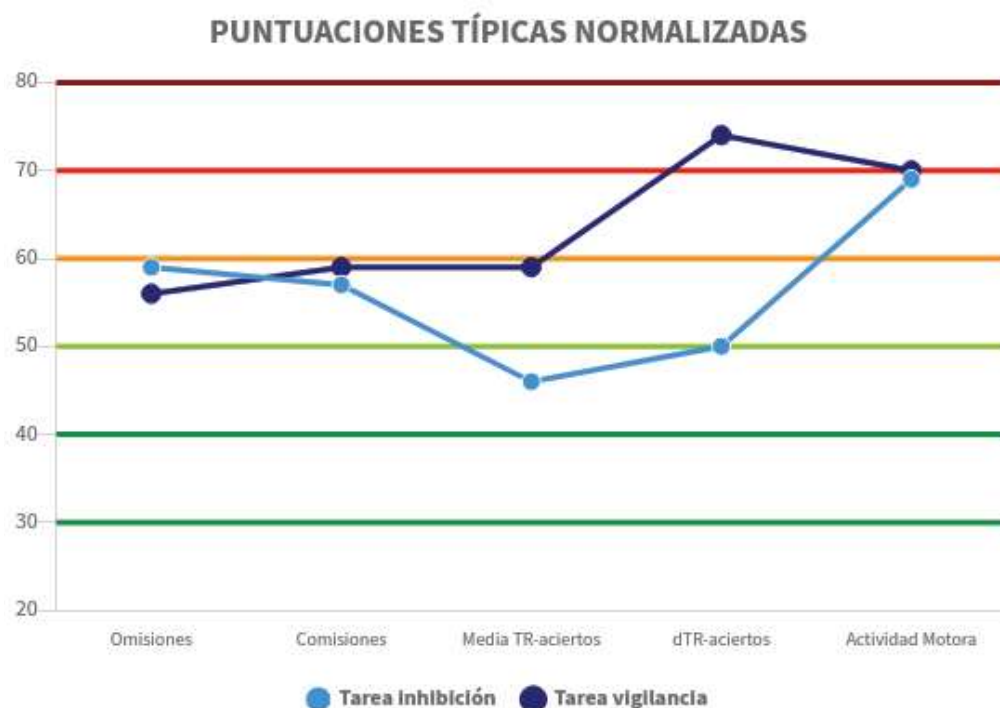


TAREA 2

1. Cuchicheo a la izquierda	AUDITIVO
2. Tos a la derecha	AUDITIVO
3. Ruido de pasos en el pasillo	AUDITIVO
4. Niño izquierda levanta la mano	VISUAL
5. Se oyen risas	AUDITIVO
6. Alguien toca a la puerta	VISUAL
7. Niño derecha levanta la mano	VISUAL

5. Tipo de ejercicio

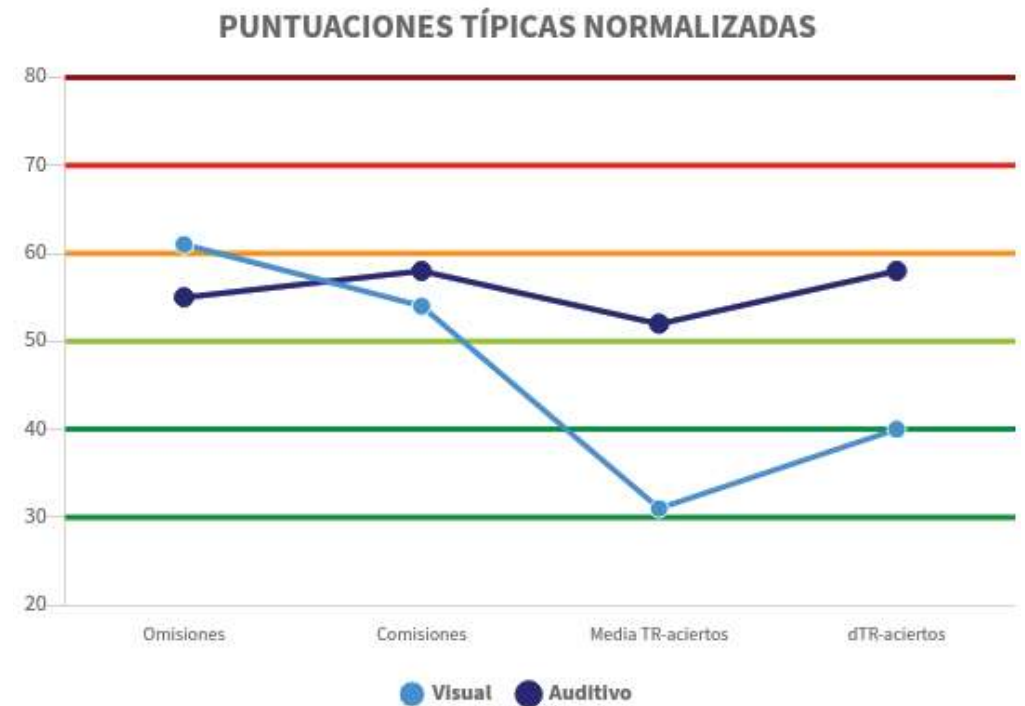
En Nesplora Aula, Adrian ha tenido que realizar dos tareas: la primera tarea llena de estímulos induce a una sobreestimulación que pone a prueba su capacidad de controlar impulsos. En la segunda, una tarea más monótona y lenta, es más difícil mantener la atención o concentración y conduce a la hipoactivación. En las siguientes tablas se muestra el rendimiento de Adrian separado por tarea.



	TAREA INHIBICIÓN			TAREA VIGILANCIA		
	PC	PD	PT	PC	PD	PT
Omisiones Totales	82	42	59	71	5	56
Comisiones totales	75	15	57	83	6	59
Media TR-Aciertos	36	795.84	46	81	1055.26	59
(σ) Desviación típica TR-Aciertos total	49	350.65	50	98	571.65	74
Actividad motora total	97	1.56	69	97	2.3	70

6. Canales sensoriales (Auditivo y visual)

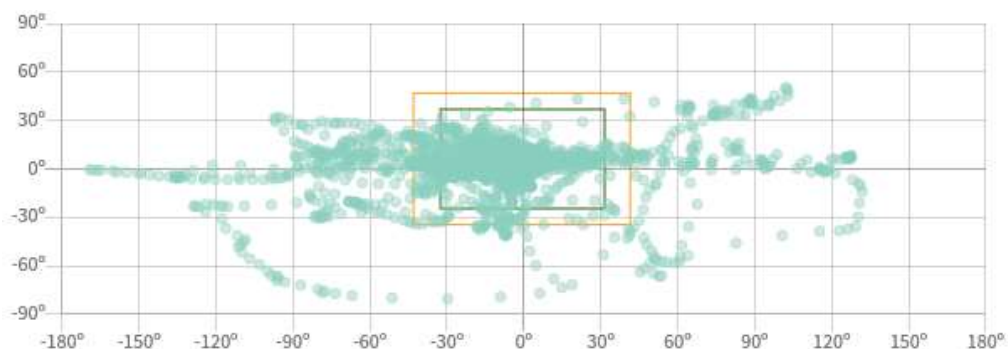
En Nesplora Aula, Adrian responde a estímulos auditivos y visuales. Podemos obtener diferencias de canal sensorial comparando los resultados entre ambos tipos de estímulos.



	VISUAL			AUDITIVO		
	PC	PD	PT	PC	PD	PT
Omisiones Totales	86	41	61	70	6	55
Comisiones totales	64	12	54	80	9	58
Media TR-Aciertos	3	547.54	31	57	1054.53	52
(σ) Desviación típica TR-Aciertos total	16	177.32	40	80	423.05	58

7. Actividad motora

Estas gráficas muestran el movimiento de la cabeza de Adrian a lo largo de toda la prueba. El marco amarillo representa la zona donde se puede ver la pizarra virtual. Fuera de ese marco es imposible realizar bien la prueba visual. El diagrama de puntos da una imagen visual de su atención a la pizarra y a la tarea general. Si ha mirado a la zona de la pizarra y no ha realizado bien la tarea, habrá que pensar en distractores internos (ver calidad de atención).

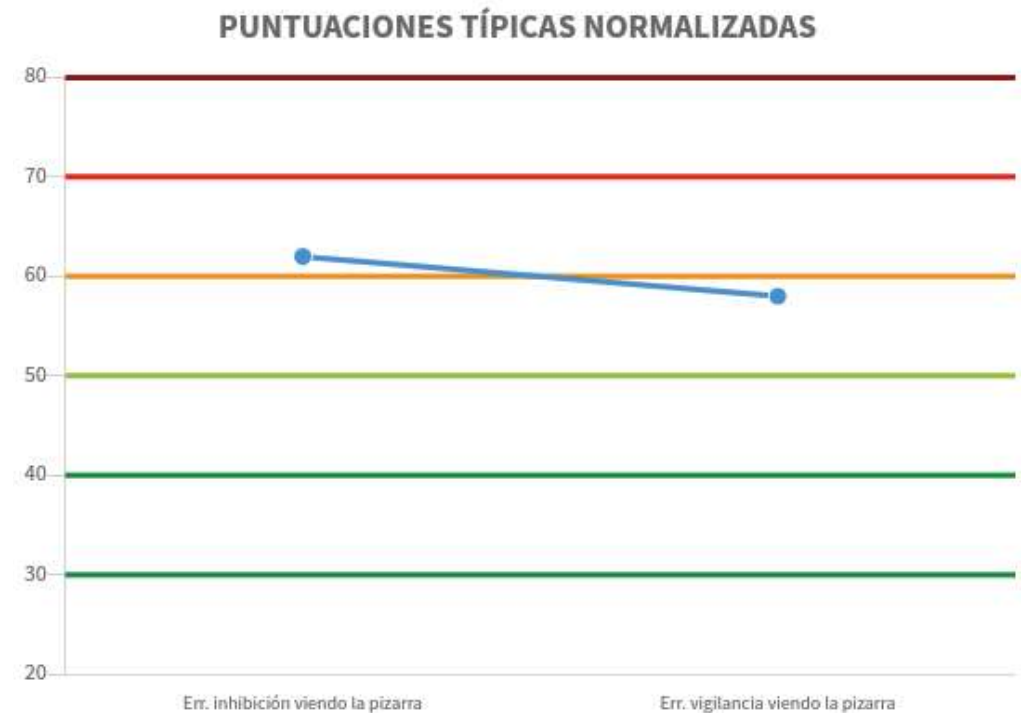


El índice de actividad motora puede reflejar, entre otras cosas, la tendencia a distraerse por estímulos externos (ver gráfica de distractores); la actividad motora estéril (sin relación con distractores) o, en el caso de poca actividad pero mala ejecución de la tarea, apuntar a distractores internos (ver gráfica de calidad de la atención).



8. Calidad del foco de atención

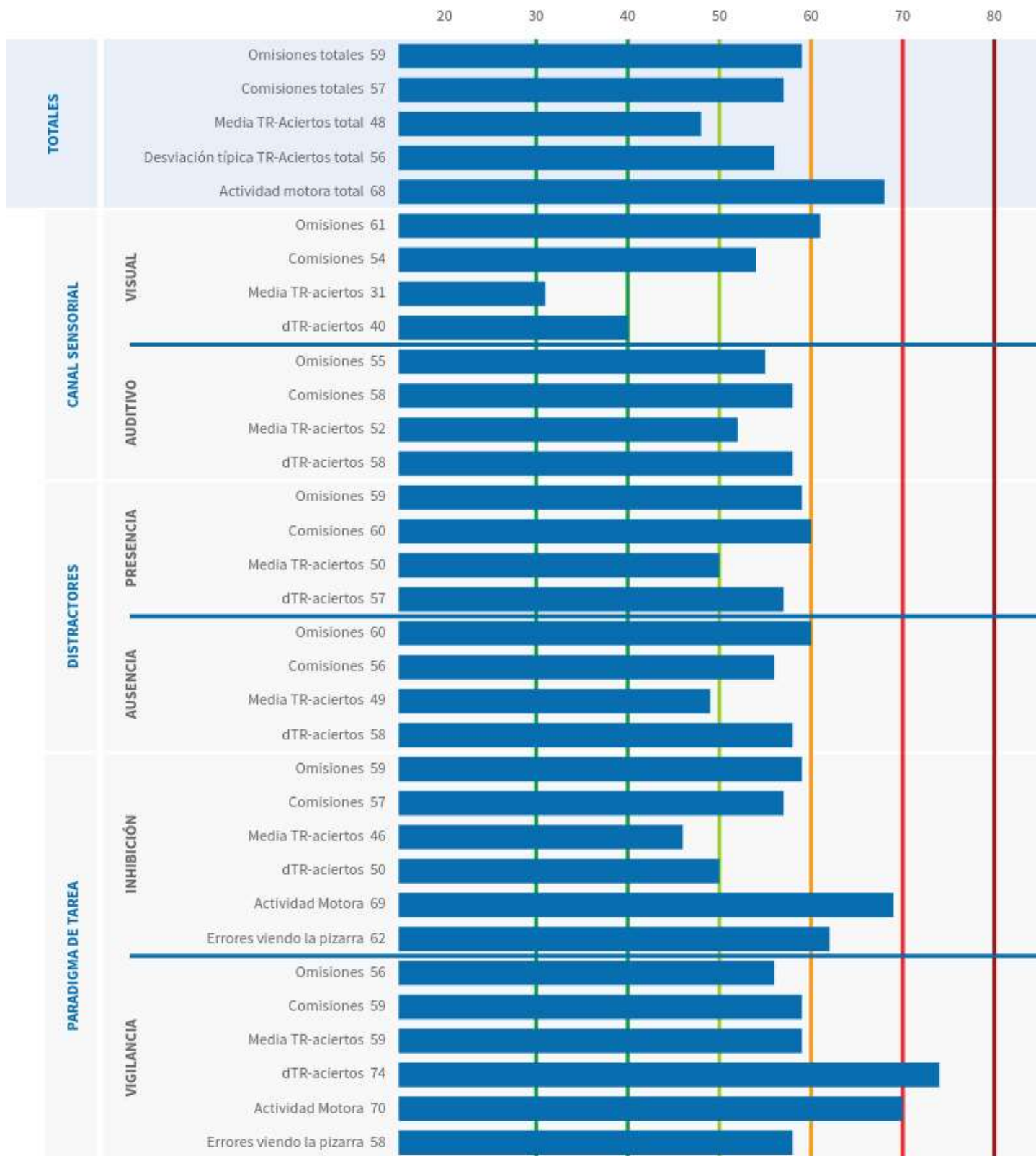
Esta medida nos permite valorar la calidad del foco atencional del niño, frente a estímulos visuales, cuando no está desviando la mirada del foco de atención. Complementa a los datos de actividad motora y nos permiten saber si la calidad de la ejecución de Adrian varía por estímulos internos o externos.



	PC	PD	PT
Errores totales en TAREA DE INHIBICIÓN viendo la pizarra	88	44	62
Errores totales en TAREA DE VIGILANCIA viendo la pizarra	78	7	58

Tabla resumen

PUNTUACIONES TÍPICAS NORMALIZADAS



10. Orientaciones

10.1 Orientaciones en función del perfil atencional

En el ámbito general, las puntuaciones de Nesplora Aula School indican sobre la ejecución de Adrian un **rendimiento mejorable** en las tareas atencionales y en base a esto se recomienda utilizar algunas estrategias para mejorar esta habilidad:

- Captar la atención del alumno/a antes de dar la explicación al grupo
- En el aula, resumir de forma individual las indicaciones dadas al grupo, y, si es posible, pedirle que exprese verbalmente lo que ha entendido
- Establecer compañeros o compañeras de supervisión y estudio con estrategias adecuadas y buen nivel de atención que ayuden al alumno/a en determinados momentos
- Fragmentar las tareas en partes, supervisando el tiempo que dedica a cada una (uso de reloj o cronometro). Intentar que las tareas sean cortas, estructuradas y motivadoras
- Dar las instrucciones a medida que vaya realizando los diferentes pasos o dejarlas escritas en la pizarra.
- Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan al alumno/a anticipar lo que viene a continuación
- Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias, partiendo de conocimientos previos y acercando los contenidos o su presentación a los intereses del alumno/a
- Fomentar la realización de ejercicios prácticos
- Descubrir junto con el alumno o alumna sus potenciales, para ayudarlo a sentirse mejor y posibilitar su desarrollo personal

10.2 Orientaciones en función del perfil de actividad motora

Por otro lado, los resultados de Nesplora Aula School muestran que **Adrian** tiene una actividad motora excesiva en comparación con su grupo de referencia, por ello se recomienda llevar a cabo estrategias para reconducir de una forma más ajustada y adaptativa la necesidad de moverse:

- Anticiparnos a situaciones de difícil manejo, elaborando previamente la estrategia a llevar a cabo. (Por ejemplo: a la salida al recreo, podríamos darle la función de ser el responsable de dejar pasar a los compañeros en grupos de 5)
- Identificar las señales que anticipan comportamientos molestos, como golpear reiteradamente la mesa con el lápiz, y reconducir hasta la realización de tareas que supongan movimiento, como repartir fichas de trabajo
- Permitir movimiento en el asiento, en ocasiones favorece la ejecución de la tarea
- Permitirle válvulas de escape, por ejemplo, posibilitar movimientos controlados (avisos al conserje, hacer fotocopias...), o hacerle protagonista de la explicación
- Posibilitar el ejercicio físico para rebajar el nivel de actividad. (Por ejemplo, antes de iniciar una sesión que requiera concentración y después de haber trabajado, permitir que suba y baje las escaleras)
- Permitir que se mueva, que se levante, que pasee, enseñándole a levantarse en los momentos más adecuados (Por ejemplo, permitir que se levante una vez haya terminado el ejercicio; o que el movimiento tenga un propósito en el aula, como borrar la pizarra o ayudar a colocar las mesas y las sillas).



Informe De Evaluación Neuropsicologica De Niños

Escala Wechesler De Inteligencia Para Niños – V (Wisc - V)

CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES WISC V			
INDICE	INDICE COMPUESTO	RANGO PERCENTIL	INTERVALO DE CONFIANZA DE 90%
COMPRESION VERBAL	97	42	91-103
VISOESPACIAL	89	23	83-97
RAZONAMIENTO FLUIDO	79	8	74-86
MEMORIA DE TRABAJO	88	21	82-95
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO	79	8	73-89
CI TOTAL	86	18	82-91

DESCRIPCION DE INDICES			
Índice	Descripción	Promedio	Resultados
Comprensión Verbal	Mide la capacidad de un individuo para comprender y utilizar el lenguaje	97	promedio
Visoespacial	Mide la capacidad para evaluar detalles visuales y comprender las relaciones espaciales, así como su habilidad para manipular mentalmente estas imágenes	89	Promedio Bajo
Razonamiento Fluido	Evalúa la habilidad para establecer relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento para identificar reglas y aplicarlas	79	limite
Memoria De Trabajo	Habilidad para registrar, mantener y manipular información visual y auditiva en la conciencia	88	Promedio bajo
Velocidad De Procesamiento	Mide la velocidad y precisión para identificar estímulos visuales, tomar e implementar decisiones	79	limite
CI Total	Medida de la inteligencia general	86	Promedio Bajo

Escalas de Comportamiento Aplicadas

ESCALA GUILLIAN PARA EVALUAR TRASTORNO DE ASPERGUER			
Subescalas	Puntaje Natural	Puntuación Escalar	Rango Percentil
Interacción Social	30	14	91
Patrones Restringidos De Conducta	23	15	95
Patrones Cognitivos	21	14	91
Habilidades Pragmáticas	17	12	75
Coeficiente De Trastorno De Asperguer	55	125	ALTO / PROBABLE

Teniendo en cuenta que DSMV nula el termino asperguer esta escala nos permite reconocer sintomatología relacionada al TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, en este paciente si impresiona síntomas relacionados, sin embargo este informe solo es evaluativo y el diagnostico esta en concepto medico del especialista tratante

CARs Puntuación (CON SIGNIFICANCIA PARA TEA)

CUMPLE DOMINIO:	NO CUMPLE LOS DOMINIOS
- Dominio relación con las personas -Dominio nivel de actividad -Dominio uso de los objetos - Dominio de Imitación -Dominio respuesta emocional -Dominio uso del cuerpo -Dominio Gusto, olfacto, tacto -Dominio adaptación y cambio -Dominio respuesta visual -Dominio Miedo -Dominio comunicación verbal -Dominio comunicación no verbal	-Dominio respuesta Auditiva -Dominio respuesta intelectual

INVENTARIO DE ESPECTRO AUTISTA (I.D.E.A)

se encontraron características propias de Autismo puntuación (30 puntos)

Cumplimiento de todas las escalas

- 1 Escala de trastorno de desarrollo social: 8 puntos
2. Escala del trastorno de comunicación y lenguaje: 6puntos
- 3 Escala de trastorno de anticipación y flexibilidad: 8 puntos
- 4 Escala de trastorno de simbolización: 8 puntos

Entrevista para el Diagnostico del Síndrome de Asperguer (A.S.D.I)

Cumple todas las áreas

Área 1: Alteraciones severas en la interacción social reciproca:6 puntos

Área 2: Intereses Restringidos: 4 puntos

Área 3: Rituales e interés: 6 puntos

Área 4: Peculiaridades del Habla y el lenguaje: 6 puntos

Área 5 : Problemas de comunicación no verbal :2 punto

Área 6: Torpeza motora: 2 puntos

Impresión diagnóstica

De acuerdo a los puntajes de la prueba de inteligencia (WISC V), alcanza una puntuación CI Total de (86) en una medida estandarizada de la capacidad intelectual dicha puntuación se clasificada dentro del nivel (PROMEDIO) que está en un nivel esperado para su edad cronológica, en relación a la muestra de estandarización, con un nivel de confianza del 90%, el CI podría estar ubicado dentro del rango (82-91) con un rango percentil de (18). El análisis realizado por CI (compuesto) muestra que uno de los aspectos con mayor destreza corresponde a los ítems relacionados Comprensión Verbal (ICV=97); mientras que los ítems de menor capacidad refiere a Razonamiento Fluido (IRF =79). De manera que, el desarrollo de diferentes habilidades se ha presentado con cierta armonía cognoscitiva el cual infiere que el coeficiente intelectual total es válido como medida intelectual. Tras las pruebas complementaria de tercera generación en evaluación neuropsicología en realidad virtual (NESPLORA) ha mostrado un desempeño esperado en áreas como atención, velocidad de procesamiento, vigilancia de información y control inhibitorio, lo que sugiere que, en contextos estructurados, el paciente puede mostrar habilidades funcionales. En contraste, se ha observado un desempeño significativamente bajo en la actividad motora, lo que podría indicar dificultades en la coordinación y la planificación motora, aspectos que son cruciales para el desarrollo de habilidades académicas y sociales, mostrando posibles disfunciones en los lóbulos frontales y parietales, áreas responsables de las funciones ejecutivas y el control motor. Las escalas comportamentales muestran síntomas que podrían estar relacionados con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) de tipo 1, caracterizado por dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. En conjunto, estos hallazgos sugieren un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista tipo 1 sin alteración estructural del lenguaje, sin déficit cognitivo, requiere apoyo sustancial (interacción social, comportamientos restringidos)

NOTA: LA ANTERIOR INFORMACIÓN NO ES DE CARÁCTER CONCLUSIVO, NO TIENE UN ALCANCE MAYOR AL DE SER UN INFORME DE CARÁCTER EVALUATIVO, NO PERICIAL, NO TESTIMONIAL, SE REQUIERE SER CORRELACIONADO DICHOS RESULTADOS CON LA VALORACIÓN DEL ESPECIALISTA TRATANTE PARA DETERMINAR UN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN PRO DEL BIENESTAR DEL PACIENTE



Recomendaciones:

Una vez concluida la valoración, se considera que la intervención debe realizarse en un trabajo integral con las diferentes especialidades así como en los contextos (colegio y familia) transfórmalos en ambientes facilitadores de aprendizaje y estabilidad biopsicosocial

-Seguimiento de psiquiatría

- Psicoterapia #10 Sesiones

- Se recomienda 10 terapias de rehabilitación cognitiva con el fin de fortalecer procesos ejecutivos, teoría de la mente y cognición social.



Laura Daniela López Guerrero

1.053.845.608 TP 173014